

Syndrome de Gougerot- Sjogren

Dr A. BELAID

Service de Médecine Interne

CHU TO

Objectifs

Reconnaitre les signes cliniques et paracliniques d'un syndrome sec

Différencier le syndrome de Sjogren des autres syndromes sec

Enumérer les critères de gravité du syndrome de Sjogren

Préciser les principes du traitement et la stratégie du suivi

plan

Introduction

Physiopathologie

Diagnostic positif : clinique , paraclinique

Diagnostic différentiel

Diagnostic de gravité

Principes du traitement

Définition – Intérêt de la question

Maladie auto-immune , caractérisée par une infiltration lympho-plasmocytaire et une destruction des glandes exocrines salivaires et lacrymales conduisant à une perte des fonctions sécrétoires
« xérostomie, xérophtalmie »

Maladie systémique pouvant atteindre plusieurs organes : articulations, système nerveux , poumon , reins

Syndrome de Sjogren isolé « primitif »,ou associé à d'autres connectivites

Maladie invalidante « altération de la qualité de vie », parfois le pronostic vital est mis en jeux

Epidémiologie - physiopathologie

Connectivite la plus fréquente , nette prédominance féminine
« sexe ratio : 1/9 » , âge : 40 - 60 ans « en moyenne 50 ans »

Multifactorielle : facteurs génétiques ,environnementaux (infections bactériennes ou virales)  activation des cellules épithéliales et réponse excessive du **système interféron** « IFN » « présent chez plus 50% patients dans le sang et les tissus cibles »  production excessive par les cellules épithéliales de la **cytokine BAFF** qui stimule la maturation et la survie des lymphocytes B

L' **hyperactivation des LB** : se traduit par la présence d'auto-anticorps Anti- SSA, anti- SSB , facteur rhumatoïde et d'une hyper – gammaglobulinémie

La signature interféron , l'hyperactivation des lymphocytes B et T : cibles thérapeutiques

Diagnostic positif : clinique

Manifestations glandulaires « Sécheresse » :

Atteinte oculaire « Xérophtalmie » : sensation de sable ou de corps étranger dans les yeux , douleurs oculaires, démangeaisons ,irritation et rougeur oculaire ,hypertrophie des glandes lacrymales dacryocystite , conjonctivite, épisclérite

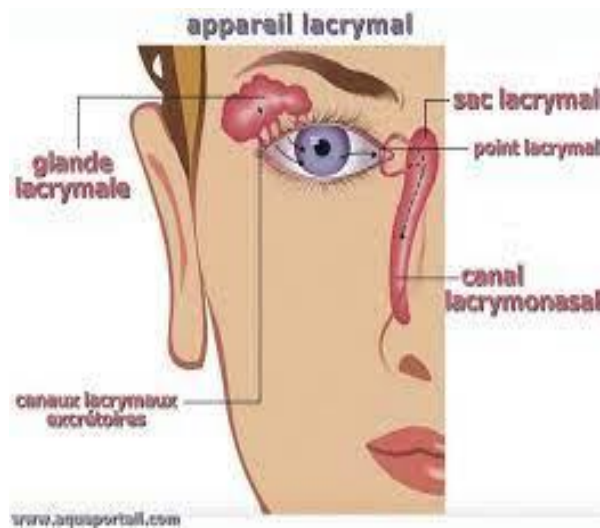
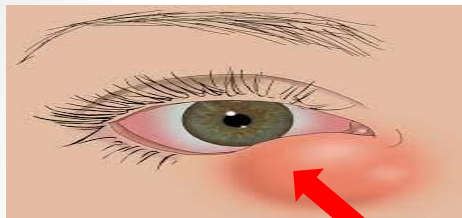
Atteinte buccale « Xérostomie » : sensation de bouche sèche , difficulté à avaler et nécessité de prendre de l'eau pour avaler , épisodes d'hypertrophie parotidienne bilatérale récidivante

Examen clinique : muqueuse sèche ulcérée, collante ,brillante ou au contraire bien humidifiée, langue lisse ,dépapillée ,fissurée , rouge , avec brulures « stomatodynies » , candidose

Examen des tissus parodontaux : saignement ,œdème ou récession des gencives, plaques caries dentaires

Hypertrophie des glandes salivaires principales « parotides et sous-maxillaires » : examen des orifices de Sténon et de Wharton

Test au sucre : morceau de sucre doit fondre en moins de 3 minutes



Diagnostic positif : clinique

Atteinte cutanée « Xérose » : infiltration lymphoïde des glandes sudorales, hyposudation peut être également liée à une neuropathie des petites fibres ; prurit , picotements sensation de brulures ,tiraillement

Manifestations fréquentes : syndrome de Raynaud , purpura hypergammaglobulinémique , vascularite cryoglobulinémique



Atteinte de la muqueuse respiratoire : rhinite ,croutes endonasales , bronchite

Atteinte de la muqueuse génitale : sécheresse vaginale , prurit, ulcérations, candidose, dyspareunie

Diagnostic positif : clinique

Manifestations extra-glandulaires : « atteintes systémiques »

Signes généraux : asthénie +++ ,amaigrissement modéré ,la fièvre oriente plutôt vers une complication

Atteinte articulaire : polyarthralgies inflammatoires des grosses moyennes et petites articulations ,non déformantes et non destructrices

Atteinte broncho-pulmonaire : toux sèche chronique, dyspnée d'effort progressive , dyspnée asthmatiforme : atteinte bronchique ou bronchilaire « syndrome obstructif à l'EFR », pneumopathie infiltrante diffuse « syndrome restrictif »

Atteinte neurologique : mononeuropathie multiple , polyneuropathie sensitive ou sensitivo - motrice, atteinte des paires crâniennes « trijumeau++», ganglionnopathie , polyradiculonévrite chronique, atteinte dysautonomique.
Atteintes centrales : pseudo-SEP, neuromyéélite optique, vascularite du système nerveux central, myélite

Diagnostic positif : clinique

Atteinte rénale : néphropathie tubulo -interstitielle «acidose métabolique hyperchlorémique hypokaliémie, hypercalciurie, sans ou avec altération de la fonction rénale , plus rarement glomérulaire

Atteinte musculaire : avec ou sans élévation des enzymes musculaires

Atteinte hématologique : lymphopénie « signe d'activité »,plus rarement neutropénie , thrombopénie auto- immune, anémie hémolytique auto-immune

Atteinte digestive : rare

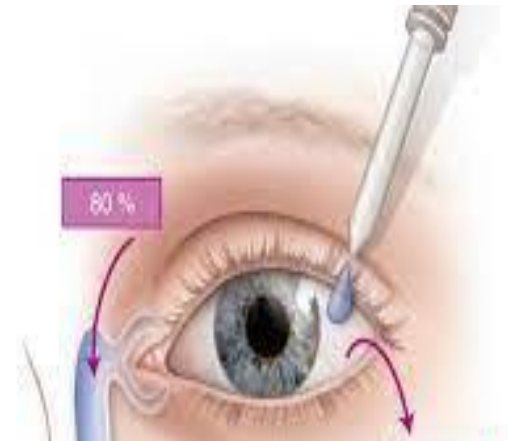
Diagnostic positif : paraclinique

Objectiver la xérophtalmie :

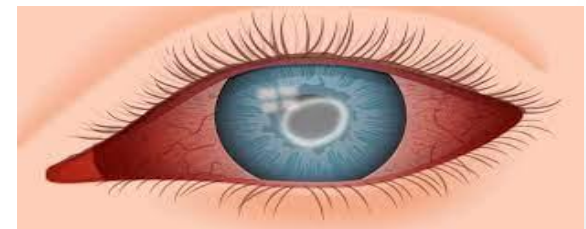
Test de Schirmer pathologique :
« < 5mm /5mn »



Temps de rupture du film lacrymal ,
pathologique si < 5 secondes ,instillation d'une
Goutte de fluorceine et mesurer le temps
nécessaire à l'apparition de la première zone de
rupture du film lacrymal après clignement



Recherche d'une kérato -conjonctivite superficielle,
Ulcère cornéen



Diagnostic positif : paraclinique

Objectiver la xérostomie :

Biopsie des glandes salivaires accessoires :
une sialadénite lymphocytaire chronique



Diagnostic immunologique :

AC anti-nucléaires « FAN » : IFI sur cellule HEp2

AC anti –SSA « Ro 52 , Ro 60 »

AC anti- SSB « La »

Autres signes biologiques :

Lymphopénie

Hypergammaglobulinémie polyclonale

Diagnostic différentiel

Devant une sécheresse buccale ou oculaire :

Médicaments : atropine , antidépresseurs , neuroleptiques, antiparkinsoniens, morphiniques , antalgiques opiacés , anticholinergiques, cannabis , tabac , cocaïne, bêta- et alpha- bloquants , benzodiazépines

Irradiation locale

Terrain : diabète déséquilibré , déshydratation, dysthyroïdie, hépatite C, B, sarcoïdose, amylose , syndromes dépressif

Devant une parotidomégalie :

Causes ORL : parotidite aigue ou chronique : lithiase, virale « ourliennes, CMV », Suppurée, tumeurs bénignes ou malignes

Causes générales : sarcoïdose , maladie à IgG 4, lymphome, diabète, cirrhose éthylique,

Diagnostic de gravité : complications

Altération de la qualité de vie : asthénie , sécheresse , douleur

Complications locales :

Oculaires : kératite ponctuée superficielle, ulcère et perforation cornéenne , blépharite

Buccales : caries dentaires , candidoses, détérioration dentaire, parodontopathies

Complications systémiques :

Dégénérescence lymphomateuse B : Altération de l' état général , fièvre , parotidomégalie persistante , syndrome tumoral ,pic monoclonal des gammaglobulines , cryoglobulinémie de type 1

Vascularite cryoglobulinémique : purpura vasculaire, phénomène de Raynaud, multinévrite sensitive, glomérulonéphrite, normo ou hypo-gammaglobulinémie

Diagnostic de gravité

Atteinte pulmonaire : PID et risque de fibrose pulmonaire

Atteinte neurologique

Atteinte rénale : risque d'insuffisance rénale chronique terminale



Traitement spécifique

Gougerot et grossesse : BAV congénital, lupus néonatal « anti-SSA , anti-SSB »

Principes thérapeutiques

Objectifs :

Améliorer la qualité de vie des patients : « asthénie , douleur, sécheresse »

Préserver le pronostic vital et fonctionnel « atteintes systémiques »

Moyens :

Traitement symptomatique de la sécheresse : non pharmacologique et pharmacologique « sécrétagogues »

Traitement spécifique des atteintes systémiques : corticothérapie systémique , immunosuppresseurs , immunomodulateurs ,biothérapie

Education thérapeutique

Modalités thérapeutiques

Sécheresse buccale :

Bonbons acides sans sucres , chewingum sans sucre, agrumes, auto- massage parotidien,

agonistes muscariniques « **pilocarpine** » à **dose progressives** ,également efficace sur la sécheresse nasale , bronchique et vaginale

Substituts salivaires : gel, spray, bain de bouche

Mesures hygiéniques : brossage régulier fluoré des dents, éviter : tabac , alcool, caféine,

Traitement des candidoses bucco-pharyngées

Sécheresse oculaire : larmes artificielles, gels lubrifiants ,collyre de corticoïdes,

Prise en charge gynécologique de la sécheresse vaginale : règles d'hygiène, lubrifiants

Modalités du suivi

Objectifs :

Préciser l'activité et la sévérité de la maladie

Dépister des atteintes viscérales infra-cliniques

Evaluer l'efficacité et la tolérance des traitements

Rechercher une éventuelle comorbidité

Evaluer les facteurs de risque vasculaires , infectieux et de lymphome

Rythme des consultations :

L'activité initiale, les atteintes viscérales, comorbidités ,le type des traitements prescrits , grossesse

Modalités du suivi

Sur le plan clinique :

Examen de la bouche à la recherche de complications locales ,contrôle ophtalmologique périodique

Examen des parotides et des sous-maxillaires

Recherche de signes généraux, de signes d'activité articulaires , neurologiques, auscultation pulmonaire, recherche d'un syndrome tumoral ,effets secondaires des traitements

Examens paracliniques :

Formule sanguine « cytopénies », Epp « composant monoclonal », fonction rénal, chimie des urines ,ionogramme sanguin et urinaire ,protéinurie des 24h, sédiment urinaire, un bilan hépatique , recherche d'une complication du traitement « ostéodensitométrie, bilan phosphocalcique »

En cas de suspicion d'un lymphome : échographie parotidienne, immunofixation protéines plasmatiques, dosage des chaines légères libres plasmatiques, cryoglobulinémie, nouvelle biopsie des glandes salivaires accessoire ou biopsie parotidienne ou d'adénopathie .